

Université de Constantine 3 Salah Bounider
Faculté de Médecine
Année Universitaire 2024/2025

Examen d'Anatomie pathologique

3^{ème} Année Médecine

Session normale

Durée 02h

Cochez les réponses Justes :

- 1. Un examen cytopathologique peut être réalisé à partir :**
 - A. D'un liquide céphalorachidien.
 - B. D'un liquide pleural.
 - C. De prélèvements fixés dans le formol.
 - D. D'appositions d'un ganglion lymphatique, communiqué non fixé au laboratoire.
 - E. D'un frottis d'exocol utérin.
- 2. Concernant la fixation tissulaire :**
 - A. La modalité de fixation habituelle des pièces opératoires est le séchage à l'air.
 - B. La fixation est indispensable au maintien de la morphologie tissulaire.
 - C. La fixation est en règle réalisée par le formol.
 - D. La fixation correspond à la photographie d'une pièce opératoire.
 - E. La fixation évite l'autolyse spontanée des tissus.
- 3. L'examen anatomopathologique extemporané effectué au cours d'un acte chirurgical :**
 - A. Est réalisé sur un prélèvement tissulaire fixé dans du formol.
 - B. Nécessite l'inclusion en paraffine du prélèvement fixé.
 - C. Permet de fournir un diagnostic rapide susceptible de modifier le déroulement d'un acte chirurgical.
 - D. Peut-être indiqué pour vérifier, au cours de l'acte chirurgical, la qualité des limites d'exérèse.
 - E. Est demandé pour faire une étude immunohistochimique.
- 4. L'Adénofibrome du sein est :**
 - A. Une tumeur de la femme âgée.
 - B. Une prolifération tumorale monoclonale.
 - C. Une prolifération tumorale glandulaire et conjonctive.
 - D. Fait de canaux avec des cellules myoépithéliales externes.
 - E. Une prolifération exclusivement mésenchymateuse.
- 5. Quels sont les facteurs associés au risque de cancérisation d'un polype adénomateux colique ?**
 - A. Un nombre plus élevé de lésions.
 - B. Une taille plus grande du polype.
 - C. Une proportion plus élevée de l'architecture villose.
 - D. Une proportion plus élevée de l'architecture tubulaire.
 - E. L'étendue de la dysplasie de haut grade.
- 6. La matrice extracellulaire :**
 - A. Détermine la qualité du tissu conjonctif.
 - B. Est incriminée dans le processus inflammatoire.
 - C. Est délimitée par la membrane basale qui en est une composante.
 - D. Ne comporte pas des capillaires sanguins.
 - E. Est une des composantes du tissu osseux.

- 7. La matrice interstitielle :**
- A. Est en remodelage continue.
 - B. Peut favoriser l'invasion tumorale.
 - C. Ne fait pas partie de la matrice extracellulaire.
 - D. Comporte une substance fondamentale dont la proportion varie selon le siège anatomique.
 - E. Est riche en glycoprotéines.
- 8. Dans le métabolisme des pigments :**
- A. Les troubles sont intra et extra cellulaires.
 - B. La choléstase hépatique n'est pas liée à un obstacle dans les voies biliaires.
 - C. La surcharge en fer est toujours primitive.
 - D. Les amas de bile intra hépatocytaire est l'expression histologique de la choléstase.
 - E. Les troubles du métabolisme du fer peuvent se voir au niveau du pancréas.
- 9. Le thrombus mixte est :**
- A. La variété la plus habituelle des thrombus.
 - B. De structure complexe, présentant une tête blanche et un corps stratifié.
 - C. Observé dans les capillaires et les petites artères.
 - D. Observé dans les vaisseaux de grand et moyen calibre.
 - E. Composé toujours d'un corps rouge.
- 10. Microscopiquement, la tuberculose folliculaire renferme :**
- A. Des cellules épithélioïdes.
 - B. Des cellules de type Langhans.
 - C. Des follicules centrés de nécrose caséuse.
 - D. Une couronne lymphocytaire.
 - E. Des follicules épithélio-giganto-cellulaires sans nécrose caséuse.
- 11. L'analyse histologique des tumeurs mésenchymateuses apprécie :**
- A. La morphologie des cellules tumorales et l'existence d'une éventuelle différenciation.
 - B. La taille de la tumeur.
 - C. L'aspect macroscopique de tumeur.
 - D. L'aspect de la vascularisation et du stroma.
 - E. La présence de remaniements nécrotiques et/ ou hémorragiques.
- 12. Concernant les tumeurs vasculaires :**
- A. Les lymphangiomes sont des tumeurs vasculaires malignes.
 - B. Les hémangiomes sont des tumeurs vasculaires malignes.
 - C. Les hémangiomes capillaires sont constitués de grandes cavités vasculaires anastomosées.
 - D. Le sarcome de kaposi est une tumeur vasculaire maligne, associé à l'infection par le virus HHV8.
 - E. L'angiosarcome est une tumeur vasculaire maligne.
- 13. La différenciation tumorale désigne :**
- A. Le nombre de mitoses.
 - B. Le degré de ressemblance histologique avec le tissu d'origine.
 - C. Un facteur histopronostique.
 - D. La présence ou non de métastases.
 - E. Toutes les réponses sont justes.
- 14. Le ki67 :**
- A. Précise le type histologique.
 - B. Est un marqueur épithélial.
 - C. Est un marqueur mésenchymateux.
 - D. Est un marqueur pronostique.
 - E. Est un indice mitotique.

15. Le tableau histologique d'une maladie auto-immune comporte :
- A. Une fibrose tissulaire.
 - B. Une atrophie des structures épithéliales tissulaires.
 - C. Un infiltrat inflammatoire fait toujours de polynucléaire neutrophile.
 - D. Un infiltrat inflammatoire fait exclusivement de lympho-plasmocytes.
 - E. Des lésions de vascularite toujours présentes.
16. Le rejet aigu d'un greffon hépatique se présente par :
- A. Des lésions de portite.
 - B. Une fibrose hépatique.
 - C. Une cholangite.
 - D. Une ductopénie.
 - E. Des lésions d'endothélite.
17. Le paraganulome nodulaire de Poppema et Lennert :
- A. Est un Lymphome Hodgkinien.
 - B. Est un lymphome Non Hodgkinien de type B.
 - C. Caractérisé par la présence de cellules tumorales en Pop-corn.
 - D. Caractérisé par la présence de cellules réactionnelles de type lymphocytaire.
 - E. Peut évoluer vers un LMNH de type B.
18. Les cellules tumorales dans le lymphome de Hodgkin sont :
- A. Des cellules de grande taille mononucléées.
 - B. Des cellules binucléées.
 - C. Des cellules momifiées.
 - D. Des lymphocytes.
 - E. Des plasmocytes.
19. En évolution clonale, le processus de la carcinogénèse passe par ces étapes :
- A. La progression.
 - B. Les métastases à distance.
 - C. L'initiation.
 - D. La promotion.
 - E. La constitution du stroma tumoral.
20. Les lésions d'athérosclérose se localisent au niveau :
- A. Des grosses veines.
 - B. Des artères élastiques.
 - C. Des veinules et artéioles afférentes.
 - D. Des coudures et des bifurcations des collatérales.
 - E. Veines hépatiques.
21. Quelles sont les complications ultimes de l'athérosclérose ?
- A. L'anévrysme.
 - B. L'AVC secondaire à une embolie.
 - C. L'infarctus du myocarde.
 - D. Les varices des membres inférieurs.
 - E. La rupture de la veine cave inférieure.
22. Dans l'infection herpétique, on retrouve :
- A. Du caséum en « fromage blanc ».
 - B. Des vésicules avec du liquide séreux en intra épidermique.
 - C. Des lésions de tuberculose.
 - D. Une fibrose d'encorbeillement.
 - E. Des inclusions intra nucléaires volumineuses.

23. La métastase à distance se caractérise par :
- A. Un autre type histologique différent de la tumeur primitive.
 - B. Une tumeur plus différenciée ou moins différenciée que la tumeur primitive.
 - C. Un envahissement lymphatique et vasculaire.
 - D. Une résistance fréquente au traitement.
 - E. Des lésions de CIS.
24. Concernant le Néphroblastome, quelles affirmations sont correctes ?
- A. Il s'agit de la tumeur rénale la plus fréquente chez l'adulte.
 - B. Il touche principalement l'enfant avant l'âge de 5 ans.
 - C. Son traitement repose uniquement sur la chirurgie.
 - D. Il peut contenir des structures différenciées comme des glomérules rudimentaires.
 - E. Il présente souvent des métastases pulmonaires.
25. À propos des mélanomes, quelles affirmations sont exactes ?
- A. Ils apparaissent uniquement sur une peau saine.
 - B. Ils ne donnent jamais de métastases.
 - C. Leurs contours sont généralement réguliers.
 - D. Ils sont constitués d'une prolifération de mélanocytes présentant un aspect pléomorphe.
 - E. Leur pronostic est étroitement lié à leur profondeur d'invasion, évaluée par l'indice de Breslow.
- Cochez-la réponse juste :
26. Dans la phase aigüe de l'inflammation, l'œdème inflammatoire :
- A. Est un phénomène passif.
 - B. Est un transsudat.
 - C. Est lié à une augmentation de la perméabilité des parois vasculaires.
 - D. Entraîne une concentration des produits toxiques.
 - E. Entraîne une accélération du courant circulatoire.
27. La contraction du tissu de réparation au cours de la phase de cicatrisation est liée à l'action des :
- A. Macrophages.
 - B. Lymphocytes.
 - C. Myofibroblastes.
 - D. Cellules géantes multinucléées.
 - ☒ E. Fibroblastes.
28. Quelle caractéristique distingue principalement un adénome d'un adénocarcinome ?
- A. Présence de structures glandulaires.
 - B. Invasion du stroma adjacent.
 - C. Production de mucus.
 - D. Absence de néovascularisation.
 - E. Localisation dans le tractus gastro-intestinal.
29. Les troubles du métabolisme des protides :
- A. Sont seulement liés à la synthèse et l'excrétion.
 - B. Se manifestent uniquement par des dépôts inter cellulaires.
 - C. Engendrent entre autres des dépôts amyloïdes.
 - D. N'affectent jamais les reins.
 - E. Epargnent le cœur.
30. Quelle est la variété d'embolie la plus fréquente ?
- A. Gazeuse.
 - B. Parasitaire.
 - C. Suppurée.
 - D. Graisseuse.
 - ☒ E. Cruorique.
31. Un abcès se distingue d'un phlegmon par :
- A. Sa richesse en Polynucléaires.
 - B. La présence de Polynucléaires altérés.
 - C. L'aspect collecté de la lésion.
 - D. L'absence de polynucléaires altérés.
 - E. Les dépôts fibrineux.

32. Parmi les propositions suivantes quel est le terme qui désigne un état précancéreux ?

- A. L'hypertrophie.
- B. L'atrophie.
- C. La dysplasie.
- D. La dystrophie.
- E. La dégénérescence cellulaire.

33. Parmi les éléments suivants indiquez celui qui définit le carcinome in situ ?

- A. L'hypertrophie épithéliale.
- B. L'hyper vascularisation.
- C. Une réaction inflammatoire péri lésionnelle.
- D. L'absence de dépassement de la basale épithéliale.
- E. L'érosion en surface.

34. Toutes ces substances peuvent déclencher une vasodilatation sauf une, laquelle ?

- A. Les Kinines.
- B. L'histamine.
- C. La sérotonine.
- D. L'opsonine.
- E. Les prostaglandines.

35. Parmi ces virus, lesquels sont oncogènes ?

- A. Virus de l'hépatite B (HBV).
- B. Virus Epstein Barr (EBV).
- C. Human T-lymphotropique virus (HTLV1).
- D. Human papilloma virus (HPV 16, 18).
- E. Toutes les propositions sont justes.

36. Dans le stade d'invasion locale du cancer, l'envahissement des cellules cancéreuses de proche en proche est défini comme :

- A. Une extension par contiguïté.
- B. Une extension par migration à distance.
- C. Des embolies vasculaires.
- D. Des engainements péri nerveux.
- E. Une métastase.

37. Concernant l'apoptose, quelle affirmation est fautive ?

- A. Elle est un phénomène physiologique programmé.
- B. Elle implique une activation de gènes spécifiques.
- C. Elle s'accompagne d'une réaction inflammatoire.
- D. Elle joue un rôle dans l'élimination des cellules indésirables.
- E. Les cellules apoptotiques sont phagocytées sans rupture membranaire.

38. Quelle tumeur embryonnaire est souvent héréditaire et liée à une mutation du gène RB ?

- A. Neuroblastome.
- B. Rétinoblastome.
- C. Néphroblastome.
- D. Hépatoblastome.
- E. Tumeur vitelline.

39. La maladie de Bowen est :

- A. Une dysplasie de haut grade.
- B. Un carcinome basocellulaire in situ.
- C. Un carcinome épidermoïde in situ.
- D. Une dysplasie de bas grade.
- E. Un carcinome épidermoïde du col utérin.

40. Le carcinome de type transitionnel a pour point de départ :

- A. La prostate.
- B. La trachée.
- C. Le larynx.
- D. Le bassin.
- E. La vessie.

Bon courage

Université de Constantine 3 Salah Boubnider
Faculté de Médecine
Année Universitaire 2024/2025

Corrigé type du contrôle d'anatomie pathologique
Session normale

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. <u>A-B-D-E</u> | 21. <u>A-B-C</u> |
| 2. <u>B-C-E</u> | 22. <u>B-E</u> |
| 3. <u>C-D</u> | 23. <u>B-D</u> |
| 4. <u>C-D</u> | 24. <u>B-D-E</u> |
| 5. <u>A-B-C-E</u> | 25. <u>D-E</u> |
| 6. <u>A-B-C-DE</u> | 26. <u>C</u> |
| 7. <u>A-B-D-E</u> | 27. <u>C</u> |
| 8. <u>A-D-E</u> | 28. <u>B</u> |
| 9. <u>A-B-D</u> | 29. <u>C</u> |
| 10. <u>A-B-D-E</u> | 30. <u>E</u> |
| 11. <u>A-D-E</u> | 31. <u>C</u> |
| 12. <u>D-E</u> | 32. <u>C</u> |
| 13. <u>B-C</u> | 33. <u>D</u> |
| 14. <u>D-E</u> | 34. <u>D</u> |
| 15. <u>A-B</u> | 35. <u>E</u> |
| 16. <u>A-C-E</u> | 36. <u>A</u> |
| 17. <u>A-C-D-E</u> | 37. <u>C</u> |
| 18. <u>A-B-C</u> | 38. <u>B</u> |
| 19. <u>A-C-D</u> | 39. <u>C</u> |
| 20. <u>B-D</u> | 40. <u>E</u> |

Dr. Azebam
Or ZENADOU
Médecin Spécialiste
en Anatomie
Pathologique